



基本資料

姓 名：葉興松

年 齡：43

性 別：男

日 期：0110/08/14

J7380072

身分證號：E122625177

單 位：進金生能源服務(股)公司

檢查結果

- 1.心臟大小正常
- 2.心臟收縮功能正常
- 3.輕度二尖瓣閉鎖不全
- 4.輕度三尖瓣閉鎖不全
- 5.心包膜正常



衛教資訊

什麼是心臟超音波？

心臟超音波是一種運用聲波（超音波）檢查心臟的方法，聲波由手持的探頭放射出去並穿透病患的體壁。這是無疼痛感、非侵入性的檢查，病患也能容忍。藉由這種即時影像，看見的就是正在發生的；透過黑白或彩色螢幕的顯示可以觀察到心臟完整解剖構造的2D影像。即時動態影像的效果可以觀察到心臟的運動，包括血液的移動、瓣膜、血管和周圍的組織。心臟超音波需要時間、耐心和技巧，且非常倚賴操作者，超音波檢查和獲得資訊的品質會受施行檢查者的影響。

心臟超音波檢查能獲得的資訊？

心臟超音波能提供關於心臟解剖學的 and 心臟功能的，這些能根本影響病患臨床處置相當重要的訊息。心臟腔室的大小、心臟功能、瓣膜的運動和功能、血流的方向和血液循環動力資訊（都普勒）、辨識腫瘤（癌症）、和評估不正常液體的蓄積，以上都是能用心臟超音波檢查獲得的醫學資訊。

心臟超音波是一個非常有用的輔助工具，但還是不能取代完整的病歷、理學檢查、和放射線學的發現（X光）。舉例來說，心臟衰竭的症狀就不能單靠心臟超音波來診斷。放射線學檢查在許多心臟病患是必要的，能補充超音波的不足。另外，一些重要的資訊關於大血管、肺部血管和肺組織是需要放射線學檢查評估的。

基本資料

姓名:	葉興松
性別:	男
出生日期:	0067/05/01 年齡:43
身份證號:	E122625177
血型:	
檢查日期:	0110/08/14
健檢編號:	J7380072
事業單位:	進金生能源服務(股)公
部門:	司
	南區事業中心
工號:	600008
身分類別:	1
X光編號:	
序號:	0005
職稱:	
醫師理學: (既往病史)	無明顯異常

體格檢查

身高(公分):	179.3
體重(公斤):	87.4
理想體重(公斤):	69.51
體溫:	
血壓(mmHg)	收縮壓:127 舒張壓: 78
脈搏(次/分):	92
呼吸(次/分):	
胸圍(公分):	
腹圍(公分):	
腰圍(公分):	97.0
臀圍(公分):	
腰腎比:	
頭部:	無明顯異常
四肢:	無明顯異常
胸部:	無明顯異常
肺部:	無明顯異常
心臟:	
節律:	無明顯異常
雜音:	無明顯異常
腹部:	無明顯異常
乳房:	無明顯異常
神經及運動系統:	無明顯異常

親愛的健診之友您好:

您至本院所作健康檢查結果已詳盡在報告書上,如有疑慮請電洽詢專線:

諮詢專線:07-3233590

諮詢時間:星期一至星期五下午2:00-5:00

☆ 體檢完成後仍需隨時注意身體狀況,如有不適,請找專科醫師做進一步診治。

眼科檢查

裸視右眼：
裸視左眼：
矯正右眼：
矯正左眼：
辨色力：
眼壓10D(<20)
其他：

1.20
1.00
右正常
右:15.0
左正常
左:18.0

心電圖

靜態心電圖：

無明顯異常

運動後心電圖：

無明顯異常

耳鼻喉檢查

結論：

婦科檢查

子宮頸抹片：

男性泌尿系統檢查

攝護腺：
(肛診)

幽門螺旋桿菌呼吸氣檢查

碳13胃幽門
螺旋桿菌：

<4.0 DOB

參考值 單位

肺功能

肺活量VC：
努力性肺活量：
第一秒用力吐
氣量FEV1：
吐氣尖端流量
PEER：
最大吐氣中段
流速FEF

3.94
3.81
3.69
8.31

L
L
L
L

25%: 8.30

L/SEC

50%: 6.77

L/SEC

75%: 2.82

L/SEC

判定Interpretation:

無明顯異常

X光檢查

胸部(CXR)：

無明顯異常

頸椎(C-SPINE)：

腹部(KUB)：

無明顯異常

腰椎正位：
(L-SPINE AP)

腰椎側位：
(L-SPINE LAT)

其他：

乳房檢查

乳房觸診：

右：
左：

腹部超音波

肝臟：
膽囊：
門靜脈：
胰臟：
脾臟：
腎臟：
其他：

中度脂肪肝、肝單純囊泡
約1.63公分
無明顯異常
無明顯異常
無明顯異常
無明顯異常
無明顯異常

各項超音波

子宮卵巢：

乳房：

攝護腺：
甲狀腺：
頸動脈：

無明顯異常
兩側甲狀腺結節右約0.4公分、
左多發性最大約2.2公分
無明顯異常

氣傳導(dB)

右耳：無明顯異常
左耳：無明顯異常
音叉

右耳：
左耳：

腸胃道攝影

上消化道系統：

食道：

胃：

十二指腸：

無明顯異常發現

無明顯異常發現

無明顯異常發現

下消化道系統：

直腸：

結論：

胃鏡檢查

結論：

非侵入性動脈脈

結論：

未達明顯血管硬化程度，無血管阻塞狀況

十年心血管疾病風險評估：

4

%

骨質密度檢查

腰椎正面：

與本國正常骨質密度參考值相比，

平均百分比

與高峰相比已流失

T值(1~-1)：

-1.00

結論：

無明顯異常

髖關節：

與本國正常骨質密度參考值相比，

平均百分比

與高峰相比已流失

T值(1~-1)：

-1.40

結論：

骨質流失

體脂肪檢測

BMI(%)：

27.19

體脂肪率(%)：

34.70

脂肪量(kg)：

30.10

除脂肪量(kg)：

56.60

體水份量(kg)：

41.40

生化檢查

Biochemistry

肝膽功能

Liver Function

總膽紅素(T-BIL)：

0.53 [0.1-1.5]

直接膽紅素(D-BIL)：

0.17 [≤0.5]

總蛋白(TP)：

7.60 [6.0-8.8]

白蛋白(ALB)：

5.10 [3.5-5.5]

球蛋白(GL0)：

2.50 [2.0-3.6]

白/球蛋白(A/G)：

2.04 [1.0-2.5]

麩草酸轉氨酶(ASOT)：

37.00 [0-42]

麩丙酮轉氨酶(SGPT)：

66.00 [0-40]

鹼性磷酸酶素(ALP)：

50.00 [32-130]

麩體基轉胺基酶素(γ-GT)：

45.00 [男:0-55
女:0-38]

腎功能

Renal Function

尿素氮(BUN)：

16.20 [8-25]

肌酸酐(Cr)：

1.40 [0.5-1.5]

尿酸(UA)：

7.70 [2.5-7.8]

腎絲球過濾率(eGFR)：

58.79 [≥60]

心臟功能

Cardiac Exm.

乳酸脫氫酶素(LDH)：

U/L

肌酸磷酸化酶素(CPK)：

131.00 [男:0-175
女:0-145]

肝炎篩檢

Hepatitis

A型肝炎抗體(HAV IgG)：

無反應

B型肝炎抗體(HBcAb)：

有反應

B型肝炎表面抗體(HBsAb)：

無反應

B型肝炎抗原(HBeAg)：

有反應

(型)肝炎抗體(Anti HCV)：

無反應

胰臟功能

Pancreatic Function

澱粉酶素(AMY)：

69.00 [0-200]

糖尿病

Diabetic Exm.

飯前血糖(A0)：

110.00 [70-120]

飯後血糖(PC)：

5.90 [4.0-6.0]

糖化血紅素(Hb A1C)：

5.90 [4.0-6.0]

電解質檢查

Electrolyte Exm.

鈣(Ca)：

mg/dL

磷(P)：

mg/dL

鈉(Na)：

mEq/L

鉀(K)：

mEq/L

氯(Cl)：

mEq/L

血液常規

Blood Routine

其他檢驗項目

白血球(WBC) :	7.03	[4.0-10.8]	單位 10 ⁹ /uL
紅血球(RBC) :	4.97	男:4.0-6.0 女:3.8-5.5	單位 10 ⁶ /uL
血色素(Hb) :	15.00	男:12.3-18.3 女:11.3-15.3	單位 g/dL
血球容積(Hct) :	43.00	男:38-52 女:33-47	單位 %
平均紅血球容積(MCV) :	86.50	[80-100]	單位 fL
平均紅血球色素素(MCH) :	30.20	[27-35]	單位 pg
平均紅血球色素素濃度(MCHC) :	34.90	[31-37]	單位 g/dL
血小板(PLT) :	301.00	[130-400]	單位 10 ³ /uL
紅血球平均寬度(RDW) :	38.00	[38-51]	單位 %
血小板平均寬度(PDW) :	15.90	[10-16]	單位 %
平均血小板容積(MPV) :	11.50	[9-13]	單位 fL
血小板容積比(P-LCR) :	36.10	[20-45]	單位 %
淋巴球數值(LY#) :	2.44	[0.8-4.9]	單位 %
單核球(Mono#) :	0.35	[0-1.8]	單位 %
嗜中性球值(Neutrophil#) :	3.99	[1.5-7.8]	單位 %
嗜酸性白血球值(Eosinophil#) :			單位 %
嗜鹼性白血球值(Basophil#) :			單位 %
帶狀中性球值(Band#) :			單位 %
紅血球沈降速率(ESR) :			單位 mm/hr

白血球分類

WBC Differential Count

嗜中性球(Neutrophil) :	56.70	[42-80]	參考值 單位 %
淋巴球(Lymphocyte) :	34.70	[21-50]	單位 %
單核球(Monocyte) :	5.00	[0-19]	單位 %
嗜酸性球:			單位 %
嗜鹼性球:			單位 %
帶狀中性球:			單位 %

同半胱胺酸 (5.0-15.0 umol/L):

10.9

尿液檢查

Urinalysis

外觀:	顏色:	比重:	酸鹼度:	白血球:	亞硝酸鹽:	尿蛋白:	尿糖:	尿酸:	尿膽素原:	尿膽紅素:	潛血:
	1.010	[1.010-1.030]	6.00	[5-8]	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性

尿液沉渣

Sediment

紅血球(RBC) :	0-1	0-5	參考值 單位
白血球(WBC) :	0-1	0-5	單位
上皮細胞(Epith) :	0-1	0-5	單位
圓柱體:			
結晶體:			
細菌:			

糞便檢查

Stool Exam.

外觀:	正常	正常	參考值 單位
潛血:	陰性	陰性	單位
寄生蟲或卵:			

癌症篩檢

Cancer Screen

阿法胎兒蛋白(AFP) :	2.30	[<20]	參考值 單位 ng/mL
腸胃道癌(CEA) :	1.26	[<5]	單位 ng/mL
腫瘤標記-乳房(CA153) :			單位 U/mL
腫瘤標記-胰臟(CA199) :			單位 U/mL
腫瘤標記-卵巢(CA125) :			單位 U/mL
攝護腺抗原(PSA) :	1.30	[0-4]	單位 ng/mL
鼻咽癌篩檢(EBV) :			單位 ng/mL
神經元特異烯醇醇(NSE) :			單位 ng/mL

血清檢查

Serological

類風濕關節因子(RA) :	6.30	[<4]	參考值 單位 mg/dL
C-反應蛋白(CRP) :			單位 mg/dL
高敏感C-反應蛋白(HS-CRP) :			單位 mg/dL

甲狀腺功能

Thyroid Exam.

三碘甲狀腺素(T3) :	0.80	[0.8-2.0]	參考值 單位 ng/mL
甲狀腺素(T4) :			單位 uug/mL
甲狀腺激素(TSH) :	1.20	[0.27-4.2]	單位 uIU/mL
游離甲狀腺素(Free T4) :			單位 ng/dL

性病篩檢

Venerel Disease Screening

梅毒血清(VDRL) :			參考值 單位
梅毒血球凝集試驗(PPHA) :			單位
愛滋病抗體(HIV Ab) :			單位

其他檢驗項目

幽門桿菌抗體(HP) :		參考值 單位
--------------	--	-----------

Conclusion & Suggestion

- * 中度脂肪肝，多運動，勿熬夜、不酗酒、勿亂服藥，少吃油膩食物，六個月後肝功能及超音波檢查。
- * 肝單純囊泡約1.63公分，目前無需治療，每年定期超音波復檢。
- * 兩側甲狀腺結節右約0.4公分、左多發性最大約2.2公分，請至門診追蹤檢查
- * 關節節骨質流失，多運動、多曬太陽、多吃富含鈣質之食物。
- * 非侵入性動脈儀結論：未達明顯血管硬化程度，無血管阻塞狀況，請多運動生活作息正常，飲食清淡，定期追蹤血管硬化程度。
- * 上腸胃道檢查無明顯異常發現，如有腸胃不適，請至腸胃科門診追蹤。
- * 您的體重已屬輕度肥胖，宜多運動，注意飲食，並控制體重。
- * 膽固醇偏高，請多運動，少攝取動物性脂肪及油膩食物，請至門診諮詢及治療。
- * B型肝炎表面抗體呈有反應，您有抗體及免疫力，不需接種B型肝炎疫苗。
- * 您的腰圍標準值應小於90公分，較不易罹患糖尿病與心血管疾病，建議多運動，注意飲食，並控制體重。
- * 肝功能異常，請勿熬夜，不酗酒，勿亂服藥，並至門診追蹤治療。
- * 腎絲球過濾率偏低，潛在性腎機能輕度損傷，六個月後腎臟專科醫師追蹤檢查。

醫師廖述發
醫字第001048號

一般檢查

◎體重

成人肥胖定義	身體質量指數(BMI) (kg/m ²)	腰圍(cm)
體重過輕	BMI<18.5	
健康體位	18.5≤BMI<24	
體位異常	過重：24≤BMI<27 輕度肥胖：27≤BMI<30 中度肥胖：30≤BMI<35 重度肥胖：BMI≥35	男性：≥90公分 女性：≥80公分

◎體脂肪檢測 BMI(身體質量指數) = $\frac{\text{體重(公斤)}}{\text{身高(公尺)}^2}$

◎高血壓 收縮壓(最高血壓)>140 毫米汞柱 舒張壓(最低血壓)>90 毫米汞柱

國民健康署血壓數值標準參考表	收縮壓(mmHg)	舒張壓(mmHg)
血壓類別		
正常血壓	<120	<80
高血壓前期	120-139	80-89
第一期高血壓	140-159	90-99
第二期高血壓	≥160	≥100

附註：舒張壓或收縮壓中只要有一項屬於高血壓範圍，即應視為『高血壓』。